

Por qué la Medicina de Continuidad

Este cuadernillo acompaña el Módulo 1. No trata de técnicas ni de protocolos, sino de la idea que da origen a todo lo demás en Humana: **el paciente cambió, y la forma de acompañarlo también tiene que cambiar.**

EL PUNTO DE PARTIDA

El paciente cambió

Nunca tuvimos mejores tratamientos, mejor tecnología ni más conocimiento. La medicina nunca fue tan buena. Y sin embargo, las instituciones están saturadas, la guardia se llena y muchos pacientes se reinternan por descompensaciones que parecían inevitables.

Durante casi todo el siglo XX la medicina se organizó alrededor de enfermedades agudas: una neumonía, una apendicitis, un infarto. Hoy las personas sobreviven muchos años con enfermedades que antes eran mortales. El paciente que más recursos consume ya no tiene una sola enfermedad: convive con varias durante años.

No estamos asistiendo al mismo paciente para el que fue pensado el sistema sanitario.

LA IDEA CENTRAL

Del episodio a la trayectoria

El sistema sigue organizado para responder a episodios, pero la vida del paciente no está hecha de episodios: está hecha de una trayectoria continua. La Medicina de Continuidad no enseña una especialidad nueva: enseña una forma distinta de observar, comprender y anticipar el cambio antes de que la enfermedad se haga evidente.

La medicina ganó años de vida. Ahora necesita ayudar a conservar vida en esos años: preservar la autonomía, prevenir deterioros y acompañar el proyecto de vida de cada persona.

La medicina del episodio pregunta: «¿Qué le ocurre hoy?». La medicina de continuidad pregunta: «¿Qué cambió desde la última vez que estaba bien?».

UN CASO

El mate por la mitad

Un paciente con insuficiencia cardíaca pasa la mayor parte de su vida en su casa, no en la institución. Surge una pregunta incómoda: ¿por qué organizamos casi toda la asistencia alrededor del lugar donde el paciente menos tiempo pasa?

Si su cuidador comenta «hoy dejó el mate por la mitad», suena irrelevante. Pero si además durmió peor, habla menos y camina menos, ya no es una observación aislada: es un patrón. Todavía no hay diagnóstico, pero ya hay un cambio objetivo. Los grandes eventos empiezan con microcambios.

EL HILO DE LA HISTORIA

No perder el hilo

Acompañar una trayectoria no es estar encima del paciente ni sumar controles: es no dejar que su historia se corte cada vez que cambia el ámbito, el turno o el profesional.

La continuidad asistencial no consiste en seguir al paciente. Consiste en no perder nunca el hilo de su historia.

El sistema tradicional toma fotos sueltas del paciente; nosotros construimos una narrativa continua, donde cada visita, cada llamado y cada observación aporta un fotograma. Ninguno explica por sí solo lo que le pasa: es la integración de todos la que deja ver la película completa.

EN LA PRÁCTICA

Qué cambia en tu día a día

No hace falta cambiar de especialidad. Alcanza con incorporar una pregunta a cada contacto: «**¿esto está igual que cuando el paciente estaba estable?**». Empezá a mirar trayectorias, no fotos sueltas.

LA IDEA PARA LLEVARTE

La medicina de continuidad empieza cuando un profesional reconoce que un paciente dejó de ser exactamente el mismo que era ayer. Ese instante, aunque parezca pequeño, es el de mayor valor clínico de toda la trayectoria.